Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde

PONTOS IMPORTANTES

- PONTOS IMPORTANTES
- O Apoio Matricial é uma estratégia de colaboração interdisciplinar entre equipes de Saúde da Família (SF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- Desdobra-se em dimensões técnico-pedagógica e assistencial, fortalecendo a capacidade resolutiva da APS.
- Sua implementação envolve reuniões regulares, consultas conjuntas e educação continuada.
- Desafios incluem a falta de conhecimento sobre o modelo e a formação acadêmica inadequada dos profissionais.

Recomendação para o Sucesso do Apoio Matricial

A educação continuada e a formação dos profissionais são fundamentais para o êxito do Apoio Matricial. Programas de capacitação auxiliam os profissionais a se familiarizarem com as práticas de matriciamento e a desenvolverem as competências necessárias para implementar eficazmente as estratégias de cuidado, sendo essencial em áreas onde há lacunas de conhecimento sobre o matriciamento [7].

No entanto, a implementação do Apoio Matricial enfrenta desafios significativos. A falta de conhecimento adequado sobre o Apoio Matricial entre gestores e profissionais de saúde pode prejudicar a aplicação das práticas e ferramentas propostas, resultando em uma implementação ineficaz. Um estudo qualitativo [2] que analisou as concepções sobre matriciamento em saúde mental, identificou que a ausência de participação ativa dos profissionais e o estigma associado às condições de saúde podem impactar a adesão ao modelo.

Alerta sobre Barreiras na Implementação

Dificuldades relacionais e organizacionais são comuns, com problemas como a fragmentação do cuidado e a ausência de uma abordagem sistemática, que enfraquecem a integração entre os serviços. A formação acadêmica inadequada dos profissionais é outro desafio identificado, pois a falta de uma base sólida em práticas de matriciamento pode limitar a capacidade de aplicação efetiva das estratégias propostas [7].

Um estudo realizado em Itapevi, SP, revelou dificuldades específicas nas ações de saúde na Atenção Básica, como a baixa capacidade de identificar demandas e riscos, a tendência à medicalização e a baixa participação dos usuários. Apesar dessas dificuldades, foram alcançados avanços significativos na percepção dos trabalhadores e na mobilização de recursos internos para o cuidado, servindo como base para a introdução do matriciamento [8].

Operacionalização do Apoio Matricial

Na prática, o Apoio Matricial se materializa através de consultas conjuntas, visitas domiciliares coordenadas, grupos terapêuticos e outras intervenções que respondem de forma abrangente às demandas variadas de saúde [6]. Essas práticas não apenas ampliam o acesso aos cuidados, mas também melhoram a continuidade do atendimento, garantindo uma resposta mais efetiva às necessidades específicas dos usuários, especialmente aqueles com condições crônicas e complexas.

Um estudo analisou as práticas e concepções do matriciamento em saúde mental a partir das perspectivas de equipes de referência, equipes matriciais e gestores [9]. Foram realizadas entrevistas com 41 participantes e observações de 110 horas das práticas matriciais. O estudo revelou duas principais concepções sobre o matriciamento: como uma oportunidade de encontro produtivo entre equipes de saúde e como uma estratégia de formação em serviço. As observações confirmaram a necessidade de criar, sistematizar e fortalecer espaços de diálogo entre equipes de referência, equipes matriciais e gestores para consolidar o matriciamento e aprimorar suas práticas [9].

Um exemplo relevante dessa abordagem é a proposta de intervenção desenvolvida na Região de Saúde de Cruz das Almas [11]. Esta proposta visa melhorar a articulação entre as Equipes de Saúde da Família (ESF) e os serviços existentes, através da criação e implementação de uma matriz de intervenção adaptada às necessidades locais. O objetivo é promover espaços para a promoção e prevenção em saúde, além de oferecer um cuidado integrado na Atenção Básica. A proposta inclui a realização de encontros de avaliação e adequação para garantir que a implementação seja eficaz e atenda às necessidades da comunidade local [11].

Potencialidades e Perspectivas Futuras

Para o futuro, o Apoio Matricial pode expandir-se através da integração intersetorial com serviços sociais, educacionais e comunitários [10]. Esta integração é crucial para fortalecer as redes de cuidado, permitindo uma abordagem mais holística dos determinantes sociais da saúde. A colaboração com esses setores pode não apenas melhorar o acesso e a qualidade dos serviços, mas também promover ações preventivas e educativas que são fundamentais para a saúde comunitária.

Além disso, a implementação de tecnologias da informação e comunicação (TICs) pode otimizar a gestão de casos e facilitar o compartilhamento de informações entre as equipes de Saúde da Família e os serviços especializados. As TICs têm o potencial de melhorar a coordenação dos cuidados, apoiar a educação continuada dos profissionais de saúde e garantir que informações cruciais estejam acessíveis para todos os envolvidos no cuidado. Essas inovações tecnológicas podem contribuir para uma gestão mais eficiente e integrada dos cuidados, elevando a qualidade dos serviços prestados.

Adicionalmente, uma perspectiva valiosa sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na Atenção Primária pode ser abordada no contexto do matriciamento. Um estudo qualitativo, desenvolvido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de um município do Rio Grande do Sul, destaca a necessidade urgente de investimentos e suporte para melhorar as ações de promoção da saúde e prevenção [12]. O artigo identifica o matriciamento como uma potencialidade para fortalecer a atuação da Atenção Primária, sugerindo que um maior investimento na formação e no suporte das equipes pode ter um impacto significativo na qualidade e eficácia dos cuidados oferecidos na Atenção Básica [12].

Além disso, um estudo qualitativo realizado na Região Sul do Brasil revelou que, apesar dos esforços para melhorar o cuidado, ainda há um descompasso entre as intenções dos apoiadores e as expectativas dos profissionais de saúde [13]. Este conflito aponta para a necessidade de reavaliação das práticas e políticas públicas para garantir que o Apoio Matricial possa efetivamente promover a saúde e a cidadania na Atenção Primária à Saúde [13].

Por fim, é crucial incorporar uma perspectiva culturalmente sensível no planejamento e na prática do Apoio Matricial. Embora os profissionais reconheçam a importância dos condicionantes socioculturais nos casos clínicos e nas interações com usuários e comunidades, a competência cultural ainda é insuficiente para uma compreensão crítica da diversidade cultural [9]. Estimular o debate sobre as dimensões socioculturais e considerar as particularidades culturais pode representar um avanço significativo no cuidado colaborativo. Integrar a cultura no planejamento e na prática não apenas melhora a adesão às intervenções, mas também aumenta a eficácia das estratégias de cuidado na Atenção Primária [9].

Conclusão

O Apoio Matricial representa uma evolução significativa na forma como a APS aborda as complexidades de saúde da população. Ao integrar saberes e práticas, esta estratégia não apenas fortalece a capacidade de resposta das equipes de SF e NASF, mas também promove uma abordagem mais humanizada e centrada no paciente. A colaboração interdisciplinar, baseada em evidências e centrada no paciente, é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde pública, garantindo cuidados mais integrados e eficazes.

REFERÊNCIAS

[6] COHEN, Marina Chansky. Impasses e potências: o matriciamento como dispositivo de cuidado. Interface (Botucatu, Online), v. 25, e200462, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.200462>.

[1] Como o apoio matricial pode ser desenvolvido na Atenção Básica em Saúde/Atenção Primária em Saúde? Biblioteca Virtual em Saúde, 2015. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/como-o-apoio-matricial-pode-ser-desenvolvido-na-atencao-basica-em-saudeatencao-primaria-em-saude/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

[3] GUSMÃO, Ricardo. Atuação do enfermeiro em saúde mental na estratégia de saúde da família. Journal of Health and Biological Sciences, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v10i1.3721.p1-6.2022>.

[4] FAGUNDES, Giselle Soares. Matriciamento em Saúde Mental: análise do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico na Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 6, pp. 2311-2322, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.20032019>.

[9] IGLESIAS, Alexandra. Matriciamento em Saúde Mental: práticas e concepções trazidas por equipes de referência, matriciadores e gestores. Ciência & Saúde Coletiva (online), v. 24, n. 4, pp. 1247-1254, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.05362017>.

[2] IGLESIAS, Alexandra. Conhecendo o matriciamento em saúde mental pela perspectiva dos matriciadores. Espaç.saúde, v. 22, 2021, pp. 1-12, 24. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353631>.

[13] OLIVEIRA, Gustavo Costa de. Ações do apoio matricial na Atenção Primária à Saúde: estudo fenomenológico. Acta Paulista de Enfermagem (online), v. 32, n. 6, pp. 674-682, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900093>.

[11] SANTANA, Elisangela Ferreira de. Proposta de Matriciamento em Saúde Mental nos municípios da Região de Saúde de Cruz das Almas. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola Estadual de Saúde Pública, Salvador, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129712>.

[10] SANTOS, Angela Maria. O matriciamento em saúde mental como dispositivo para a

formação e gestão do cuidado em saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva (online), v. 30, n. 04, e300409, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300409>.

[12] SANTOS, Elitiele Ortiz dos. Avaliação das estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na rede psicossocial. Escola Anna Nery (online), v. 27, e20220110, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0110pt>.

[5] SOUSA, Paulo Henrique Caetano de. Relato da implantação do matriciamento em um município cearense: dos desafios às conquistas. Rev. baiana saúde pública, v. 45, n. 4, pp. 241-251, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n4.a3422>.

[7] VASCONCELO, Marilena Silva de. Conhecimento de gestores e profissionais da rede de atenção psicossocial sobre matriciamento em saúde mental. Ciênc. cuid. saúde, v. 18, n. 4, e43922, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v18i4.43922>.

[8] YAMAGUTI, Claudiney Augusto. Grupos de reflexão em Saúde Mental: possibilidade de interlocução entre a Saúde Mental e a Atenção Básica no município de Itapevi – SP. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), v. 20, n. 1, pp. 132-138, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1009105>.

Links para Atualização:

1. *Ministério da Saúde - Política Nacional de Atenção Básica (PNAB): < https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/atencao-primaria-a-saude/politica-nacional-de-atencao-basica-pnab>*

2. *Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - Atenção Primária à Saúde: < https://aps.bvs.br/>*

3. *Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC): < https://www.sbmfc.org.br/>*